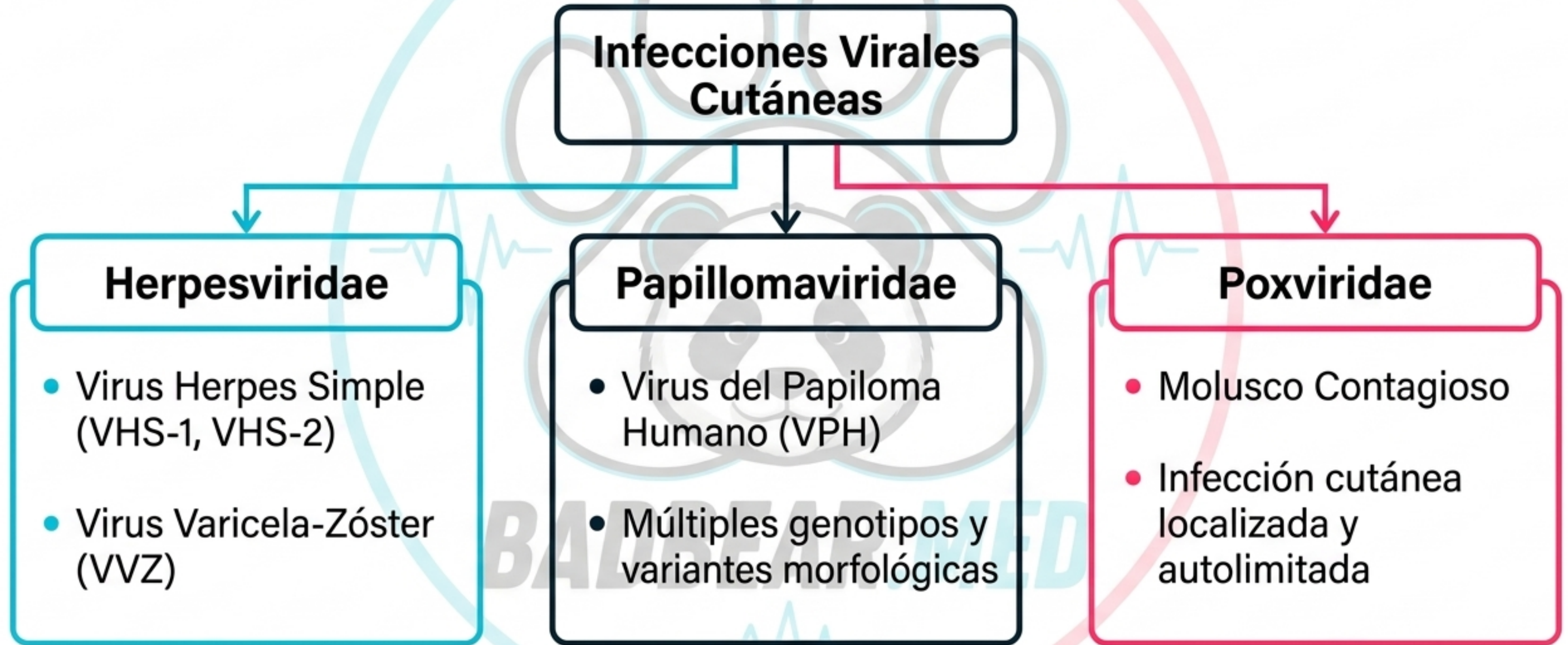


# Guía de Estudio Detallada de Infecciones Virales Cutáneas

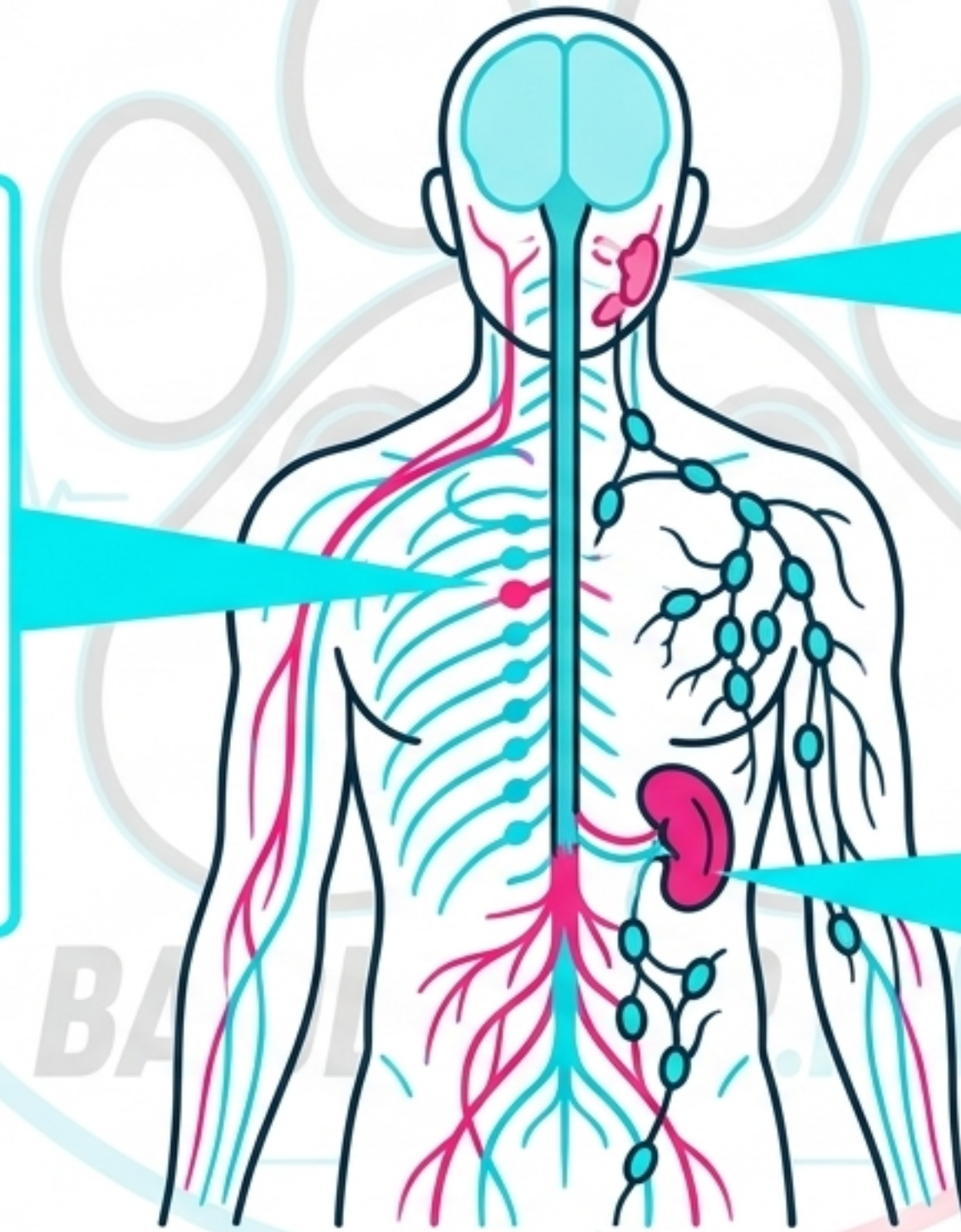
Proyecto Clínico **BADBEAR.MED**

*BADBEAR.MED*

# Taxonomía de las Principales Familias Virales Dermatológicas



# Estados de Latencia en la Familia Herpesviridae



## Nervios Sensitivos y Ganglios de la Raíz Dorsal

**Subfamilia Alfa:** VHS-1, VHS-2, VVZ (Herpes tipo 3).

*Nota clínica: Residen en ganglios nerviosos y monocitos. Su reactivación genera síntomas neurológicos severos.*

## Glándulas Salivales y Linfocitos T

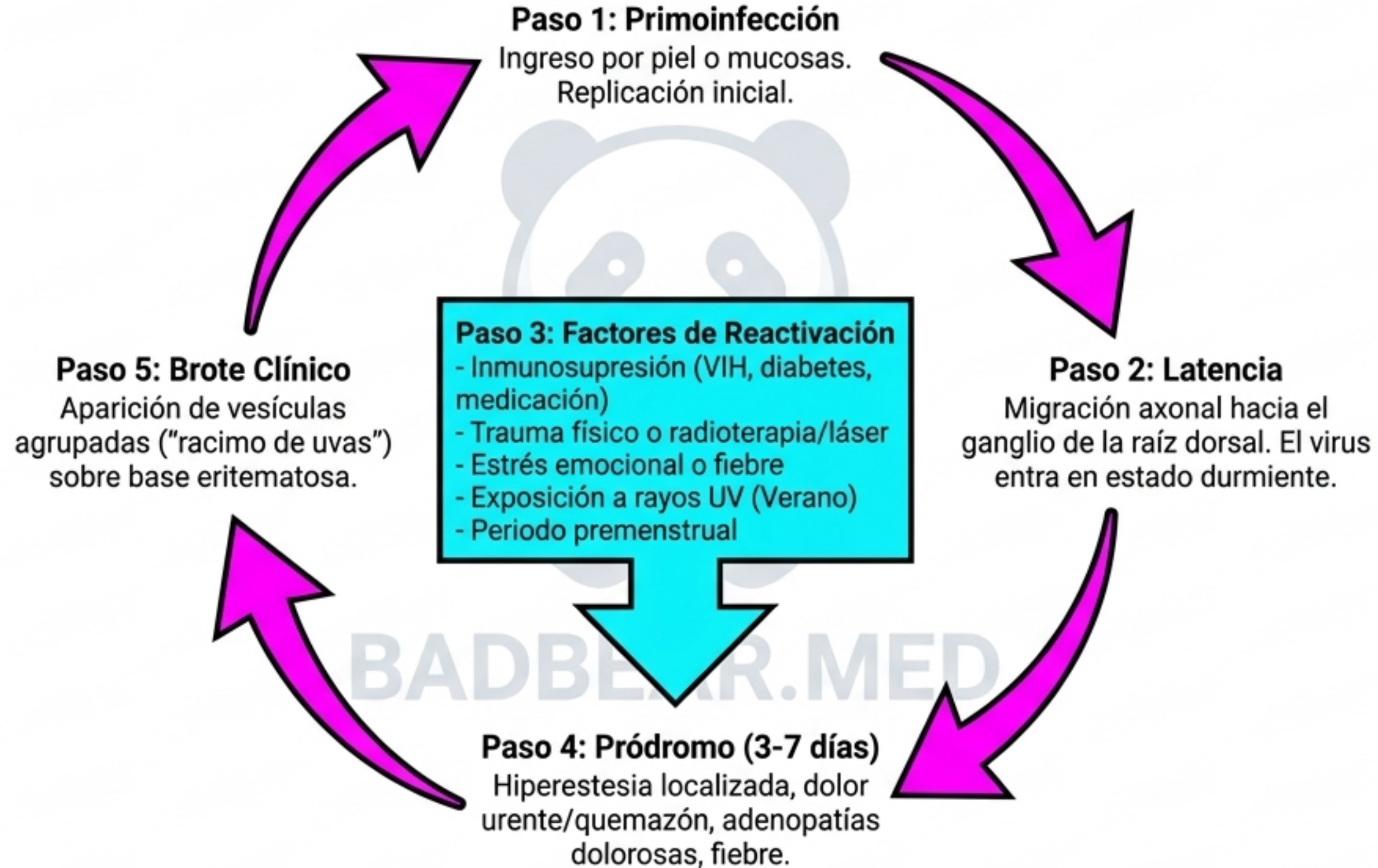
**Subfamilia Beta:** Citomegalovirus (CMV), VHH-6, VHH-7.

## Linfocitos B y Macrófagos

**Subfamilia Gamma:** Virus Epstein-Barr (VEB), VHH-8 (Sarcoma de Kaposi).

*Nota clínica: VEB está asociado a linfomas cutáneos tipo B y T.*

# Fisiopatología y Ciclo de Reactivación del Herpes Simple



# Diferenciación Diagnóstica y Epidemiológica: VHS-1 frente a VHS-2



| VHS-1 (Herpes Oro-labial)                        | VHS-2 (Herpes Genital)                                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Oro-labial, facial                               | Genital, perianal                                                                |
| Saliva, contacto directo en niñez                | Contacto sexual, ITS más frecuente                                               |
| Causa 10-30% de infecciones genitales            | Causa 10-20% de infecciones orolabiales debido a cambios en hábitos sexuales     |
| Frecuentemente asintomática en niños, faringitis | Altamente dolorosa, edema marcado, síntomas sistémicos, ulceraciones prolongadas |

# Protocolo de Diagnóstico y Algoritmo Terapéutico del VHS

## Diagnóstico

**Eminentemente clínico.** Pruebas de apoyo: Tinción de Tzanck (células gigantes multinucleadas),  
**Anticuerpos IgG/IgM** (diferencia fase aguda vs crónica).

**\*Iniciar terapia idealmente antes de las 72h del brote\***

### Primoinfección Labial

Aciclovir 200 mg  
(5 veces al día por 7-10 días)

### Primoinfección Genital

Aciclovir 400 mg  
(5 veces al día por 7-10 días)

### Infecciones Recurrentes (Ambos)

Aciclovir 400 mg  
(Cada 8 horas por 7 días)

### Terapia Supresora Crónica

Para pacientes con  $\geq 6$   
episodios al año o  
inmunosuprimidos (VIH).  
Aciclovir 400 mg (Cada 8  
horas durante 6 a 7 meses).

# Patogenia del Virus Varicela-Zóster: Reactivación Dermatómica



## Origen

Reactivación del virus latente tras una primoinfección de varicela.

## Trayectoria Anatómica

Migración viral a través de un nervio sensitivo específico.

## Ubicación Predominante

El dermatoma torácico es el más frecuentemente afectado.

## Presentación Clínica

Dolor prodromático severo (urente, lancinante) seguido de erupción vesículo-ampollar unilateral que respeta la línea media.

# Complicaciones Clínicas y Manejo Farmacológico del Herpes Zóster

## Neuralgia Posherpética

La complicación más frecuente. Dolor crónico por necrosis neuronal tras la resolución de las costras.

## Síndromes Específicos

Síndrome de Ramsay Hunt (afectación facial/óptica/auditiva).  
Riesgo de disminución de agudeza visual y meningoencefalitis en seniles.

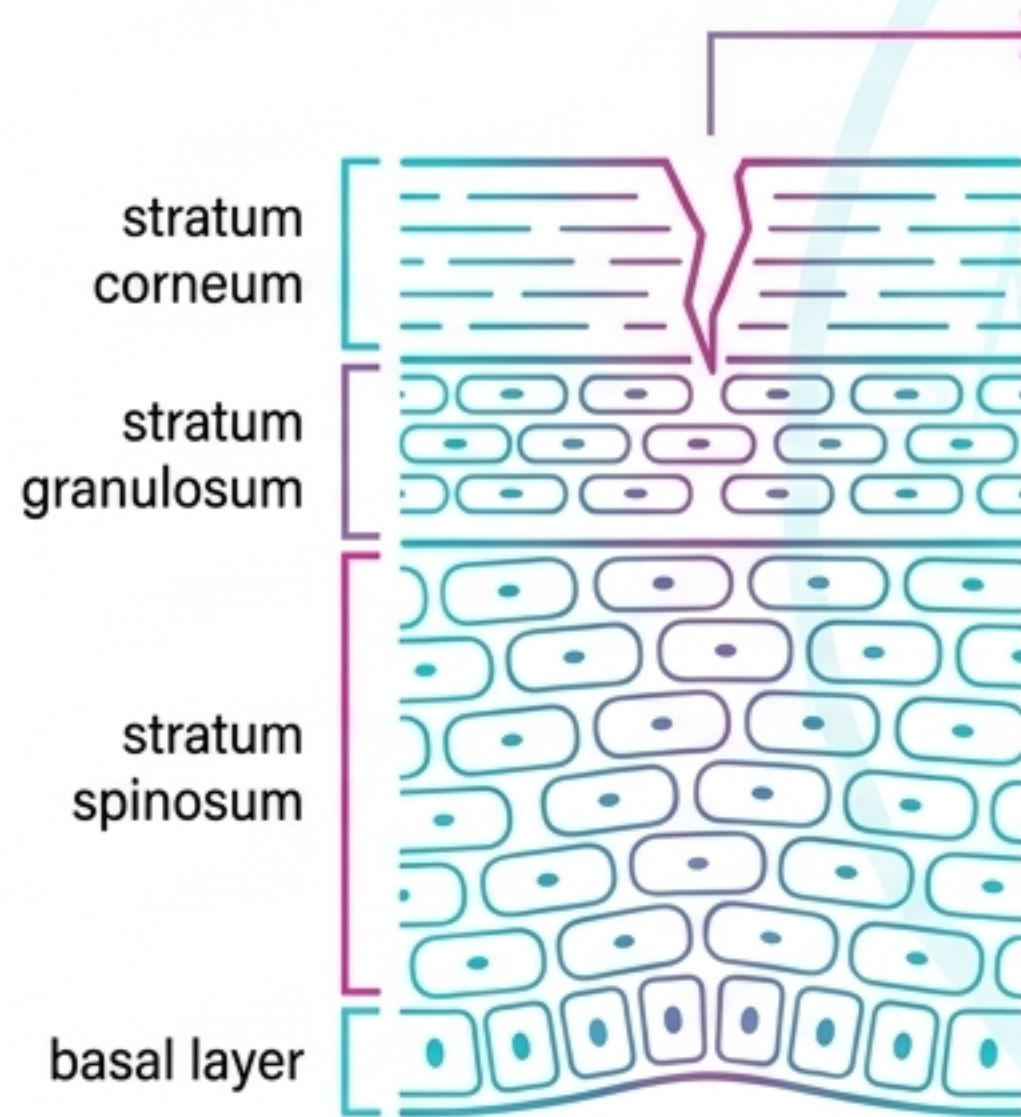
## Zóster Diseminado

Exclusivo en inmunosuprimidos.  
Definido por la presencia de >20 vesículas fuera del dermatoma primario, cruzando la línea media.

## Protocolo de Tratamiento

- **Dosis Primaria:** Aciclovir 800 mg (5 veces al día).
- **Dosis Recurrente:** Aciclovir 800 mg (3 veces al día por 7-10 días).
- **Manejo del Dolor:** Gabapentina, Pregabalina o Amitriptilina para prevenir la neuralgia posherpética.

# Fisiopatología y Riesgo Oncogénico del Virus del Papiloma Humano



- 1. Microtrauma:** Puerta de entrada (fisuras, maceración) a través de la barrera cutánea alterada.
- 2. Infección Basal:** El virus alcanza e infecta los queratinocitos en la capa basal.
- 3. Migración y Alteración:** Los queratinocitos modificados migran hacia la capa córnea, generando hiperqueratosis y el tumor benigno (verruga).
- 4. Autoinoculación:** Diseminación por fricción, rascado o afeitado (efecto isomórfico).

## Clasificación de Genotipos

### Bajo Riesgo:

1, 2, 3, 4, 10 (Verrugas cutáneas), 6 y 11 (Condilomas benignos).

### Alto Riesgo Oncogénico:

16, 18, 31, 33, 35 (Asociados a Ca. de cérvix, pene, recto, y Papulosis Bowenoide).

# Atlas Clínico Morfológico: Variantes de Verrugas por VPH



**Verruga Vulgar:** Pápulas/placas rugosas, hiperqueratóticas. Especial cuidado si son periungueales (riesgo de alteración irreversible de la matriz ungueal).



**Verruga Filiforme:** Variante facial. Base con espículas finas que pueden queratinizarse formando un "cuerno cutáneo" (requiere biopsia excisional para descartar carcinoma).



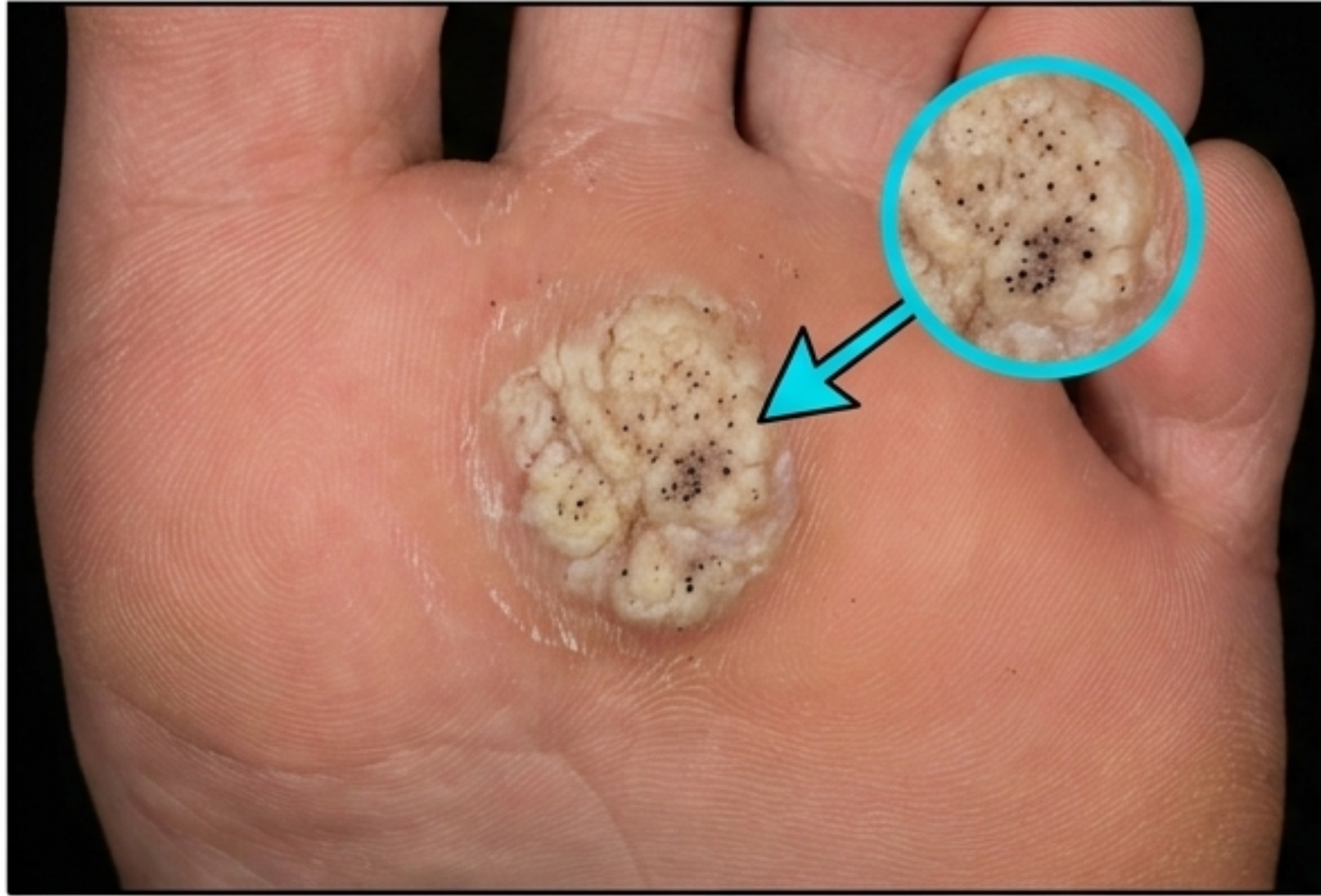
**Verrugas Planas:** Pápulas eucrómicas o hiperpigmentadas, ligeramente elevadas. Frecuentes en fototipos altos, cara, brazos y manos.



**Verruga Genital (Condiloma Acuminado):** Tumores exofíticos en forma de coliflor. Altamente contagiosos, crecimiento rápido en pacientes inmunosuprimidos.

# Desafío Diagnóstico: Verruga Plantar frente a Callo (Heloma)

## Verruga Plantar (VPH Tipo 1)



## Callo / Heloma



- **Signo Patognomónico:** Presencia de capilares trombosados (puntos negruzcos o rojizos).
- **Ubicación:** Zonas de apoyo pero interrumpe los dermatoglifos (líneas de la piel).
- **Sangrado:** Sangrado puntiforme al deslaminar.
- **Aspecto:** Placa hiperqueratósica amarillenta y uniforme.
- **Vasculatura:** Ausencia de puntos negruzcos (sin vasos trombosados).
- **Origen:** Fricción mecánica severa y repetitiva, no viral.

# Protocolos de Destrucción Lesional para VPH

**Principio Terapéutico:** No existe tratamiento curativo específico para el virus; el objetivo clínico es la destrucción física o química de la lesión.



- **Método de Elección: Crioterapia**

- **Mecanismo:** Termocauterización por congelamiento.
- **Ventajas:** No produce sangrado ni vaporización del virus, minimiza el riesgo de contagio al médico.



- **Alternativas Químicas**

- **Ácido Salicílico / Láctico** (Queratolíticos tópicos eficaces para lesiones hiperqueratósicas).
- **Tricloroacético o 5-Fluorouracilo.**



- **Métodos con Riesgo (Advertencia)**

- **Electrocirugía/Láser:** Riesgo de vaporizar el virus y generar infección en el tracto respiratorio del operador si no se usa extracción de humo adecuada. Evitar en lesiones múltiples.

# Poxviridae: Identificación Patognomónica del Molusco Contagioso



**Etiología:** Infección exclusiva del ser humano causada por Poxvirus.

**Morfología Clásica:** Pápulas perladas, nacaradas o blanquecinas, firmes.

**Signo Clave:** Centro umbilicado. (En algunos casos se aprecia como una costra hemática central o una simple depresión blanca).

**Transmisión:** Contacto directo piel con piel o autoinoculación.

# Contexto Clínico y Enfoque Terapéutico del Molusco Contagioso

| Perfil del Paciente |                                            | Presentación Clínica                                                                                                    | Tratamiento                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | <b>Pacientes Pediátricos</b>               | Tronco, cara, extremidades superiores. Benigno y autolimitado. (Alerta: evaluar ubicación genital por riesgo de abuso). | Queratolíticos tópicos (ácido salicílico) o Crioterapia (en >9 años).                             |
| 2                   | <b>Adultos Inmunocompetentes</b>           | Considerada una Infección de Transmisión Sexual (ITS). Ubicación predominantemente genital, púbica o perianal.          | Curetaje (extirpación mecánica de la lesión y la secreción central). Rápido y altamente efectivo. |
| 3                   | <b>Inmunodeprimidos (VIH Estadío SIDA)</b> | Lesiones diseminadas, gigantes o faciales atípicas. Progresión agresiva y resistente.                                   | Requiere biopsia obligatoria y manejo sistémico agresivo de la enfermedad de base (TARGA).        |

# Matriz Maestra de Síntesis: Infecciones Virales Cutáneas

| Enfermedad (Virus)       | Lesión Primaria               | Patogenia / Latencia                  | Complicación Clave              | Tratamiento de 1ra Línea         |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Herpes Simple (VHS-1/2)  | Vesículas en "racimo de uvas" | Ganglios nerviosos<br>Inmunosupresión | Meningoencefalitis / ITS        | Aciclovir (200-400mg)            |
| Herpes Zóster (VVZ)      | Vesículas sobre dermatoma     | Reactivación en raíz dorsal           | Neuralgia Posherpética          | Aciclovir (800mg) / Gabapentina  |
| Verrugas (VPH)           | Pápulas hiperqueratósicas     | Infección basal por microtrauma       | Carcinoma Espinocelular (16/18) | Crioterapia / Destrucción física |
| Molusco Contagioso (Pox) | Pápulas perladas umbilicadas  | Contacto directo / ITS en adultos     | Diseminación masiva (VIH)       | Curetaje / Queratolíticos        |